

TEMA 6.6 • INFECTOLOGÍA

Rabia y Tétanos

PERFIL EUNACOM 1.05.1.006
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Rabia y Tétanos — Manejo y Profilaxis

Rabia

Epidemiología y ciclo

- **Reservorio:** Murciélagos. - **Vector hacia humanos:** Mascotas (perros, gatos). - **Prevención de salud pública:** Vacunar a mascotas (no se puede vacunar murciélagos ni exterminarlos). - La vacuna antirrábica **no tiene contraindicaciones absolutas** (ni embarazo, ni inmunosupresión) por la letalidad de la enfermedad.

Cuándo indicar vacuna antirrábica (post-exposición)

TABLA 6.6.1: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Contacto con murciélago (aunque no haya mordida)	Vacunar
Mordida por animal no observable (ej. perro callejero suelto)	Vacunar
Animal mordedor sintomático o que muere días después	Vacunar
Animal salvaje inusual (kique, lobo marino, zorrillo)	Vacunar
Mordida por animal observable (perro o gato con dueño)	Observar al animal 10 días . Si el animal sano → no vacunar.

Clínica y Tratamiento

- Encefalitis grave: agresividad, **disfagia**, parálisis, insuficiencia respiratoria → 100% letal sin tratamiento. - Tratamiento: Soporte + Inmunoglobulina G antirrábica específica (eficacia limitada — solo 8 sobrevivientes documentados en la historia).

Tétanos

Patogenia

- Herida infectada con **Clostridium tetani** (esporas en tierra, restos vegetales) → toxina tetánica → espasmos musculares. - Aplica en: heridas, quemaduras, mordeduras.

Cuándo indicar vacuna antitetánica

TABLA 6.6.2: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Vacunado hace < 10 años	No hacer nada
Vacunado hace > 10 años	Dosis de refuerzo (1 dosis)
Esquema incompleto	Completar esquema
Nunca vacunado + herida sucia	Vacuna × 3 dosis (mín. 1 mes entre dosis) + Inmunoglobulina G antitetánica (Ig ATT)

EUNACOM CRITERIOS

La **IgG antitetánica** solo se da cuando el paciente **nunca ha sido vacunado** Y la herida está sucia/contaminada. No se da solo por herida sucia si el paciente ya tuvo vacunas previas.

Clínica y Tratamiento

- Espasmos musculares generalizados dolorosos, opistótonos. Letalidad 30%. - Tratamiento: Inmunoglobulina antitetánica + Penicilina G EV (o Metronidazol EV) + Benzodiazepinas (para espasmos) + Soporte ventilatorio si necesario.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 6 años es traído porque encontró un murciélago muerto y lo manipuló con las manos. No presenta heridas visibles. ¿Cuál es la conducta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Rabia y Tétanos. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Vacuna antirrábica: NO tiene contraindicaciones (ni embarazo ni inmunosupresión) por letalidad 100%.
- Indicaciones vacuna rabia: contacto murciélagos, animal no observable, animal sintomático/muerto, animal salvaje inusual.
- Animal observable: observar 10 días. No observable: vacunar. Ya no importa la provocación.
- Tétanos: vacunar ante cualquier herida. IGG antitetánica solo si nunca vacunado + herida sucia.
- Tétanos >10 años desde última vacuna: refuerzo. Nunca vacunado: mínimo 3 dosis separadas por 1 mes.
- Clínica tétanos: espasmos musculares generalizados + opistótonos. Letalidad 30%. Tratamiento: IGG + penicilina/metronidazol EV + benzodiazepinas.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (RABIA Y TÉTANOS)

PREGUNTA 1

Niño de 6 años es traído porque encontró un murciélago muerto y lo manipuló con las manos. No presenta heridas visibles. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Observar por 10 días y vacunar solo si presenta síntomas
- B)** Vacunar de inmediato contra la rabia
- C)** No requiere vacuna ya que no fue mordido
- D)** Administrar solo inmunoglobulina antirrábica
- E)** Solicitar serología para rabia antes de decidir

PREGUNTA 2

Agricultor de 55 años sufre herida cortante con alambre oxidado en el campo. Refiere que nunca ha sido vacunado contra el tétanos. La herida tiene restos de tierra. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Vacuna antitetánica en esquema de 3 dosis solamente
- B)** Inmunoglobulina antitetánica solamente
- C)** Vacuna antitetánica en 3 dosis más inmunoglobulina antitetánica
- D)** Una dosis de refuerzo de vacuna antitetánica
- E)** Antibióticos profilácticos con penicilina oral

PREGUNTA 3

Mujer embarazada de 20 semanas es mordida por un perro callejero que no se puede localizar. ¿Cuál es la conducta respecto a la vacuna antirrábica?

- A)** Está contraindicada en el embarazo, observar evolución
- B)** Postergar la vacunación hasta después del parto
- C)** Vacunar de inmediato
- D)** Esperar a localizar al perro para observarlo 10 días
- E)** Administrar solo inmunoglobulina antirrábica por ser más segura en embarazo

RESUMEN: RABIA Y TÉTANOS

Esta clase se enfoca en la profilaxis de rabia y tétanos. Para rabia, el ciclo va de murciélagos (reservorio) a mascotas y de ahí a humanos. La vacuna antirrábica no tiene contraindicaciones (ni embarazo ni inmunosupresión) por la letalidad del 100%. Se indica ante: contacto con murciélagos, mordedura de animal no observable, animal sintomático o muerto, y mordedura de animal salvaje inusual. La clínica es encefalitis grave con disfagia, parálisis y muerte por insuficiencia respiratoria. Tratamiento: soporte más inmunoglobulina antirrábica (muy baja eficacia). Para tétanos (*Clostridium tetani*), la vacuna se indica ante cualquier herida. Si última vacuna <10 años: no vacunar. Si >10 años: refuerzo. Si esquema incompleto: completar. Si nunca vacunado: al menos 3 dosis separadas por 1 mes. Si nunca vacunado más herida sucia: vacuna más inmunoglobulina antitetánica. Letalidad 30%. Clínica: espasmos musculares generalizados, dolorosos, opistótonos. Tratamiento: inmunoglobulina antitetánica, antibióticos (penicilina EV o metronidazol EV), benzodiazepinas y soporte.